



-עדכון אחרון – אפריל 2026-

פרק 21

פינוי רפואי - עקרונות, שיקולים וטכניקה

כותבים בגרסת אפריל 2026:

איתי פאר, ענבל גוזני, ג'סי אופנהיימר, יובל רווח, שי לוי, ענבל דים, הראל גרשגורן, גל חנצ'ין, בר זמר-טוב שוורץ, אלון אחימור, מיכאל מלקין, פבל איידלמן, טבע אמיר, עקיבא אסתרסון, אביב גלבר, אבי בנוב, ארתור שפירו.

עיקרי העדכונים

1. כתיבת הפרק.
2. הפינוי המוסק מחייב את המטפל הבכיר בשטח בביצוע פעולות ב-8 שלבים שונים: תכנון מקדים, דיווח ראשוני על אירוע והעלאת דרישה לפינוי מוסק, הגעת כוח רפואי לזירה, הערכת הצורך בפינוי מוסק – אשרור או ביטול, חיתוך מצב והעברת דיווח רפואי מלא, פתיחת המנחת וניהולו, חבירה בקשר לצוות המוסק, כניסת מסוק למנחת, חבירה לפי אופציה וגישה למסוק.



מבוא

צמצום משך הזמן מפציעה ועד קבלת טיפול דפינטיבי הינו יעד מרכזי ואבן יסוד של מערכות טראומה בכלל ובשעת מלחמה בפרט. השלב הראשון בפינוי הרפואי עשוי לעיתים להתבצע באופן רגלי, אך חלקו הארי של הפינוי מתבצע באופן רכוב או מוסק. בשלב זה, הפרק שלפניכם מתמקד בעיקר בפינוי מוסק. בעתיד יתווסף חלק מקדים, בתחילתו של הפרק, שיסקור עקרונות והיבטים של הפינוי הקרקעי על מנת להקיף את שלב הפינוי הרפואי בשלמותו.

פינוי מוסק הוא כלי חשוב בשרשרת הפינוי, המאפשר הגעה מהירה של צוות רפואי מיומן, בעל יכולות רפואיות מתקדמות, ומאפשר פינוי מהיר למרכז רפואי. **פינוי מוסק הוא אמצעי אחד בתוך סל יכולות הפינוי, הנבחר במתארים מוגדרים בהם קיים לכך יתרון ברור ביחס לחלופות.** ההחלטה על פינוי מוסק דורשת שיקול דעת והתאמה למצב המבצעי ולמצבם הרפואי של הפצועים. ההחלטה דורשת היכרות מוקדמת עם הגזרה, אפשרויות הפינוי השונות, וזמני הפינוי הצפויים בכל אחת משיטות הפינוי. מפקדי הרפואה נדרשים לשקול את כלל ההיבטים ולהמליץ למפקד האג"מי על שיטת הפינוי. קיום שיח רצוף בין המדרגים, בין גורמי הרפואה והמפקדים ועם חיל האוויר, חשוב להצלחת המשימה וניהול הסיכונים.

במתארים רבים, הפינוי המוסק מקצר משמעותית את זמן הגעת הפצוע לבית החולים. ניתוח של נתוני הפינוי המוסק של פצועים דחופים שאושפזו מגזרות התמרון הצפוני והדרומי במלחמת 'התקומה' (בין התאריכים 27/10/2023-31/7/2025) הדגים זמן פינוי מוסק חציוני של 69 דקות – קצר ב-31 דקות מזמן הפינוי החציוני הרכוב שעמד על 100 דקות. בקרב פצועים שפונו מוסק כ-35% הגיעו לביה"ח תוך שעה, לעומת כ-18% בלבד בפינוי הרכוב. עם זאת, במצבים וגזרות מסוימים הפינוי הרכוב היה קצר מהמוסק (ראה פירוט בנספחים).

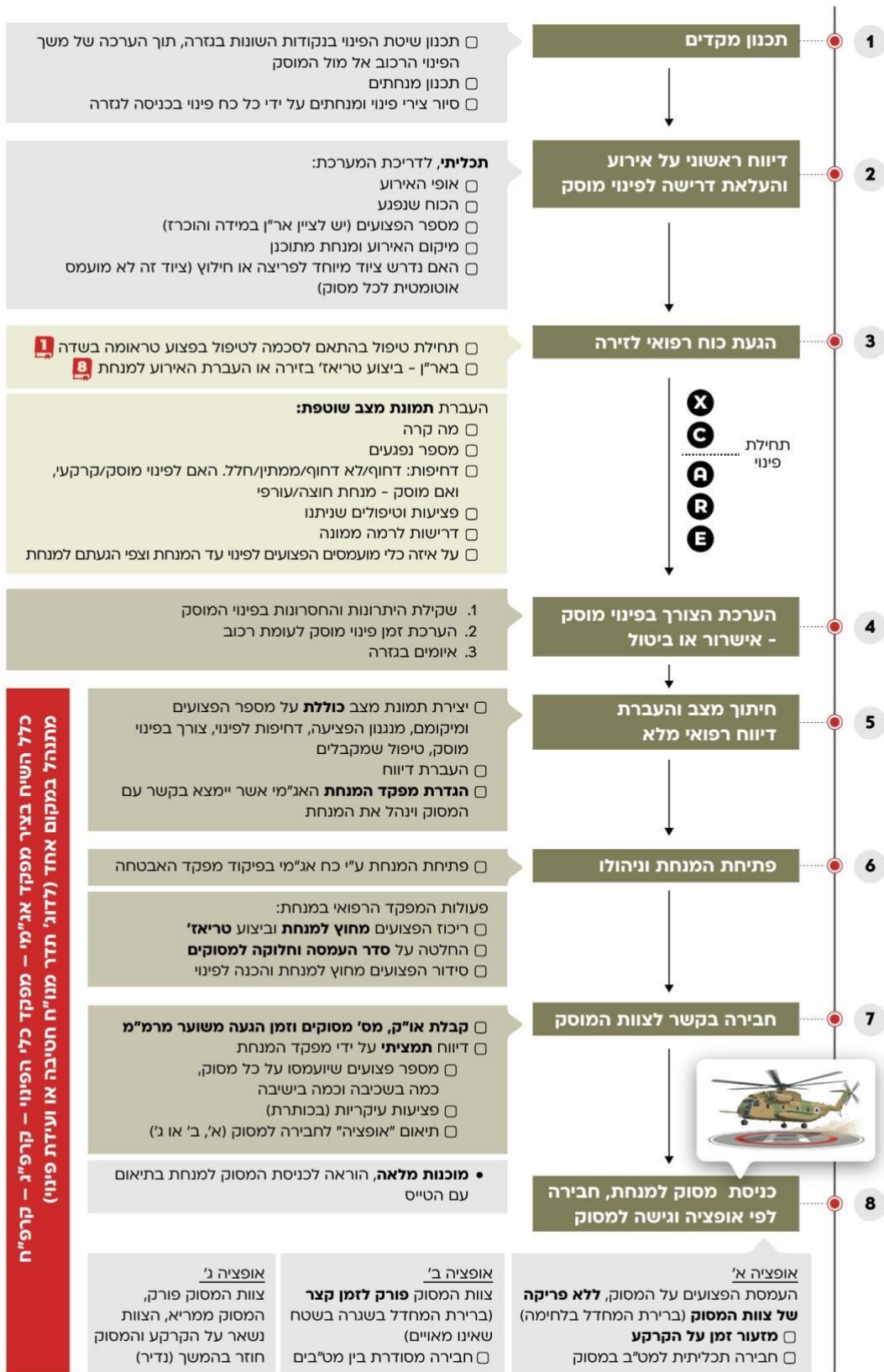
פרק זה מתאר את מהלכו המלא של פינוי מבצעי מוסק, מגדיר את מושגי היסוד, מפרט את השיקולים השונים, ודן בטכניקות ובממשקים בין הכוח הקרקעי לכוח המוסק. דגש מיוחד ניתן לחשיבות הזמן, הבטיחות, והתיאום בין הכוחות הקרקעיים לצוות המוסק.

הפרק נועד לדרג המט"ב בשטח ועד קצין הרפואה הגדודי, במתאר מאויים ובמתאר שאינו מאויים, וסוקר את השלבים בדרך לפינוי רפואי מוסק: הכנות מקדימות, שיקולים לפינוי מוסק, דרישת המוסק, גיבוש תמונת מצב, העברת דיווח, הכנת המנחת והפצועים ותהליך החבירה.

הבנה מעמיקה של הפרוטוקול, והקפדה על ביצועו, הם מפתח להצלחת המשימה, ולמזעור הסיכונים לפצועים, לכוחות הקרקעיים ולצוות המוסק.



פרוטוקול



זוהא רלס

סקר שניוני



ביאור הפרוטוקול

1. תכנון מקדים

חלק מתוכנית הפינוי בנוהל הקרב כולל תכנון מנחתים רלוונטיים – הן בעורף והן בשטחי האויב. תכנון המנחתים נגזר מהתוכנית המבצעית של המסגרת, תוך התמקדות בחץ הכחול, פריסת כוחותינו והאיומים מצד האויב – ובהתאם **יתבצע על ידי האג"ם בשיתוף עם גורמי רפואה, קציני סיוע אווירי, מודיעין והנדסה**. אישור המנחתים מתבצע ע"י חיל האוויר ובעזרת קצין הסיוע האווירי. **בבט"ש, במרבית המקרים קיימים בגזרה מנחתים שאושרו מראש על ידי חיל האוויר**.

יש לקחת בחשבון מספר תנאים בבדיקה של התאמת שטח למנחת:

- **גודל**: 30x30 מטרים לינשוף, 50x50 מטרים ליסעור.
 - עדיפות **לקרבה לציר** המאפשר הגעה ברכב או רק"ם.
 - **פנוי ממכשולים**: קרקע נוחה, פנויה, מישורית, ללא מכשולים, שאינה בסמוך לכבלי חשמל, וללא חפצים העלולים להישאב לרוטור המסוק.
- ככל הניתן, מנחת מאושר יהיה משולט והכניסה אליו תחסם לרכבים.
- בנוהל הקרב, יש לתכנן מראש את שיטת הפינוי בנקודות השונות בגזרה, תוך הערכה של משך הפינוי הרכוב אל מול המוסק. יש להגדיר כוח לאבטחת המנחת וכוח לניהול המנחת והנחתה אשר יודעים להגיע אל המנחת בכל אירוע, לספק חיפוי לקרוב ולרחוק, ולהנחית את המסוק.**

במהלך ניהול הקרב בלחימה, יתקיימו פעולות יום-יומיות לוידוא רלוונטיות וכשירות המנחתים, כגון - סיור מנחתים, **קפ"ק פינוי יומי** ווידוא מול גורמי ח"א שכלל המנחתים בגזרה מאושרים לנחיתה בעת הצורך. **סיור מנחתים יתבצע ע"י כל כוח פינוי בעת כניסה לגזרה** או אישור מנחת חדש, לצורך היכרות עם הצירים ודרך הכניסה למנחת. **בקפ"ק הפינוי היומי** בדרג הגדוד והחטיבה, במסגרת הגדרת שיטת הפינוי בכל מסגרת, יסקרו גם כלל המנחתים הרלוונטיים לתוכנית הפינוי וכשירותם ויוגדר מנחת ברירת מחדל עבור כל אחת מהמסגרות.

בבט"ש סיור מנחתים יתבצע בעליה של כוח לתעסוקה מבצעית בגזרה.

2. דיווח ראשוני על אירוע והעלאת דרישה לפינוי מוסק

העלאת דרישה ראשונית לפינוי מוסק צריכה להתבצע קרוב ככל הניתן לזמן תחילת האירוע, זאת לאור משך הזמן להקפצת הצוות המוסק וזמן העלאת המערכות המתווספים לזמן הטיסה לנקודת



החבירה. את הדרישה הראשונית למסוק יש להעלות לרמה ממונה והיא תועבר מהחטיבה או האוגדה לתא השליטה בחיל האוויר אשר יקצה מסוקים לאירוע, ויתאם את המעטפת המבצעית שתלווה את כניסת המסוק.

הקצאת הכוחות תהיה תלויה בתמונת המצב שמתקבלת מכוחות הרפואה הקרקעיים, ועל כן יש לשאוף להעביר דיווח מפורט ככל הניתן.

הדיווח הראשוני יהיה תכליתי ויכלול מידע מצומצם שימשש לדריכת המערכת:

- אופי האירוע.
 - הכוח שנפגע.
 - מספר הפצועים (יש לציין אר"ן במידה והוכרז).
 - מיקום האירוע ומנחת מתוכנן.
 - האם נדרש ציוד מיוחד לפריצה או חילוץ (ציוד זה לא מועמס אוטומטית לכל מסוק).
- הדיווח יועבר בדרך כלל ע"י גורם אג"מי, אך יכול להתבצע גם על ידי כוח רפואי.

3. הגעת כוח רפואי לזירה והעברת דיווח

עם הגעת צוות רפואי לנקודת האירוע, מתחילה להיבנות תמונת מצב מפורטת. הדיווחים מכאן והלאה יתבצעו בתג"ם, ככל הניתן.

הדיווח יתבצע לפי השפה הרב מדרגית האחידה בדיווחים רפואיים:

- מה קרה.
- מספר נפגעים.
- סיווג הפצועים לפי דחיפות – דחוף, לא דחוף, ממתין או חלל – ולפינוי מוסק או קרקעי, ואם מוסק – למנחת חוצה/מאויס או עורפי/שאינו מאויס.
- פציעות והטיפולים שניתנו (יורחב בהמשך במהלך הפינוי הקרקעי ובחיתוך המצב).
- דרישות לרמה ממונה: כוחות רפואה ופינוי נוספים לזירה, אישור או ביטול ההחלטה על צורך בפינוי מוסק.
- על איזה כלי מועמסים הפצועים לפינוי עד המנחת וצפי הגעתם למנחת.

4. הערכת הצורך בפינוי מוסק

ככלל, בפצוע דחוף השיקול המרכזי בבחירה בפינוי מוסק הוא שיקול הזמן. כאשר אין יתרון זמן משמעותי לפינוי המוסק, יש להעדיף פינוי רכוב. בנוסף לזמן הטיסה לאירוע ולביה"ח הקרוב, חשוב לקחת בחשבון גם את זמן הזנקת המסוק (כ-15 דק'), זמן החבירה והנחיתה, וזמן הנסיעה מהמנחת בבית החולים עד לחדר הטראומה.



ספר הטראומה והרפואה המבצעית

בפינוי משטח לחימה יש לשקול את מצבו של הפצוע והדחיפות לפינוי אל מול האיומים במרחב. כעיקרון מנחה, לפצועים בהם נשקפת סכנה לחיים בטווח זמן קצר יש להעדיף פינוי של הפצוע באופן המהיר ביותר, ולשקול לבצע זאת גם תוך סיכון הכוח. במצבים אלו, קיימת חשיבות עליונה לשקף את תמונת המצב לציר הפיקודי ולרמה המקצועית הממונה.

זיהוי פצוע עם סכנה לחיים בטווח זמן קצר דורש הערכה קלינית ונתון לשיקול דעתו של המטפל בשטח, במידת הצורך תוך התייעצות עם רמ"מ מקצועית. דוגמאות לפצועים שעשויים להתאים להגדרה זו: דמם בלתי נשלט, ירי לגו, צורך בהחייאת בקרת נוקים, פצוע מחוסר הכרה, פצוע הנוזק להנשמה בלחץ חיובי וכד'.

לעומת זאת, בפצועים דחופים בהם לא נשקפת סכנה מיידית לחייהם – יש לשקול פינוי רכוב לבית החולים או למנחת עורפי ברמת איום נמוכה יותר.

יתרונות הפינוי המוסק:

- **קיצור זמן הפינוי** – כתלות בזמן ובמרחב, במצבים רבים הפינוי הרכוב צפוי להיות ארוך משמעותית מהפינוי המוסק.
- **עבירות** – המסוק מאפשר פינוי כאשר תנאי השטח, צירי הפינוי או התנאים המבצעיים אינם מאפשרים פינוי רכוב יעיל או בטוח של הפצוע.
- **אפשרות לפינוי למרכזי על רפואיים מרוחקים** – כאשר הפציעה באזור גיאוגרפי פריפריאלי ללא מרכזי טראומה קרובים, יתרון נוסף של הפינוי המוסק הוא הגעה למרכז על לטראומה בזמן קצר או דומה לפינוי רכוב לבי"ח בעל יכולות מוגבלות יותר. למען הסר ספק, **אין הנחיה גורפת** לפנות למשל פצועי ראש באופן מוסק על מנת שיגיעו למרכז בעל יכולות נויורוכירורגיות.
- **פינוי מספר נפגעים ע"י צוות רפואי מנוסה ומיומן** – המסוק מאויש במספר מטפלים בכירים מנוסים, ויכול לפנות מספר פצועים במקביל תוך מתן טיפול מיטבי.
- **אמצעים מתקדמים לטיפול** – על גבי המסוק קיימים אמצעי ניטור מתקדמים, ויכולות להחזר נפח איכותי ע"פ עקרונות החייאת בקרת נזקים בשדה (דם מלא בכל מסוק).
- **יכולות חילוץ** – צוות המסוק יודע לבצע משימות חילוץ ממגוון תוואי שטח ופריצה.

חסרונות הפינוי המוסק:

- **מגבלת נחיתה בשטח** – מסוק דורש מנחת מתאים. לעיתים השטח מאפשר איתור מנחת שכזה בקלות, אך לעיתים ההגעה למנחת מאריכה בצורה משמעותית את זמן הפינוי הכולל. קיימת



פינוי רפואי – עקרונות, שיקולים וטכניקה

אפשרות לביצוע "מנחה" (ריחוף מסוק ופתיחת דלתות ללא נחיתה) או פינוי כבל במתארים מורכבים.

- **"מטרת איכות" עבור האויב וסיכון הכוח** – מסוק מהווה יעד מועדף לאש אויב.
 - **חשיפת כוח בשטח** – נחיתה מסוק חושפת את הכוח הקרקעי ואת המנחת, ולעיתים אף "שורפת" את המנחת משימוש נוסף בעתיד.
 - **מגבלת מזג אוויר** – תנאי מזג אוויר קשים עלולים להגביל את נחיתה המסוק.
- יכולות טיפול ופינוי: פינוי מוסק מתבצע על ידי אחד משני מסוקים של חיל האוויר המאוישים על ידי לוחמי ומטפלי היחידה הטקטית לחילוץ מיוחד (669).

סוג המסוק	כוח רפואי	טיפול מיטבי	פינוי מקסימלי (במקרי קיצון)
ינשוף	חוליה: רופא בכיר, פרמדיק ו-3 חובשים לוחמים	2 פצועים שוכבים	3 שוכבים, על חשבון יכולת טיפול
יסעור	צוות: רופא בכיר, 2 פרמדיקים ו-5 חובשים לוחמים	3 פצועים שוכבים	6 שוכבים, על חשבון יכולת טיפול

5. חיתוך מצב והעברת דיווח רפואי מלא

לאורך הפינוי הקרקעי הרכוב אשר כולל הערכה יסודית יותר של הפצועים והתחלת הטיפול בהם, יש צורך **בהעברת דיווח חוזר ועדכני** בתג"ם (כמפורט בסעיף 3), **ליצירת תמונת מצב מלאה**, לרוב בתדר של הכוח המסתייע. עם הגעת הלבנה הגדודית או תחילת הפינוי למנחת הדיווחים יועברו בתדר אליו מאזינים כלל הכוחות (כמו **תדר מנו"ח חטיבה או ועידת פינוי**, (על מנת לאפשר שיח ישיר בין כלל מפקדי הפינוי והרפואה, בדרג הגדוד וחטיבה לצוות המטפל על המסוק). שימוש ב-101 דיגיטלי מאפשר גם הוא העברת מידע רציפה לדרגי הטיפול הבאים.

בטיפול בחולים עם מצבי חירום שבשגרה, ישנה חשיבות להעברת תמונת מצב מלאה תוך התייחסות למערכות השונות ומצב החולה. במידה והתבצעו בדיקות נוספות (למשל אק"ג) יש לציין זאת ולצרף בשחלוף עם המסוק. במידה ומדובר בילדים יש לציין את גילו וגודלו של הילד.

בשלב זה, יש להגדיר בקשר מי המפקד האג"מי אשר נמצא בקשר מול המסוק ומנהל את המנחת.



6. פתיחת המנחת וניהול

ניהול נכון של המנחת הוא בעל חשיבות עליונה להצלחת הפינוי ולבטיחות כלל המעורבים. יש לוודא שכלי הפינוי מתמקמים מחוץ למנחת. הפצועים, הכוח הרפואי והאלונקאים ימתינו גם הם בשולי המנחת.

שלושה מפקדים מעורבים בניהול המנחת:

- **מפקד אבטחה וכוח אג"מי לאבטחת המנחת:** יוגדרו בנוהל הקרב. נדרש להיות זמין למשימה בכל עת ונפרד מכוח הפינוי. לכן בעדיפות יהיה זה כוח אג"מי מוגדר שבגזרתו נמצא המנחת. באחריותו פתיחה של המנחת.
- **מפקד המנחת:** ככלל יהיה מפקד אג"מי מכוח הפינוי אשר (1) יבצע את החבירה בקשר למסוק להעברת מידע חיוני, (2) ידווח למסוק כשהצוות על הקרקע מוכן לכניסת המסוק ו- (3) יסמן למסוק את המנחת באמצעות רימון עשן/סטיקלייט א"א/פאנל הנחתה (בשולי המנחת ולא במרכז) בהתאם לדרישת הטייס ובעיתוי שיקבע על ידו. יש להגדיר בנוהל הקרב מי יהיה המפקד בצוות המנחת, ולוודא שלצוות המנחת קיים ציוד מתאים בהתאם לדרישת חיל האוויר לסייע להנחתה. כל כלי פינוי צריך להכיל את הציוד הדרוש להנחתה.
- **מפקד רפואי:** יש לקבוע מפקד רפואי יחיד. תפקידו חבירה למפקד האג"מי, סידור המנחת, ביצוע טריאז' מתכלל, החלטה על סדר העמסת הפצועים, וידוא שהפצועים מוכנים להעמסה, וביצוע חבירה רפואית למט"ב במסוק. פעולותיו בפירוט:

א. ריכוז הפצועים במנחת וביצוע טריאז'

במקרה של אירוע רב נפגעים, יש לבצע טריאז' מלא גם בהגעה למנחת ע"י המפקד הרפואי. כלל הפצועים ירוכזו בכניסה למנחת בצורה מסודרת, כל פצוע יעבור תחת ידיו של המפקד הרפואי ובהתאם להחלטתו המט"ב שטיפל במהלך הפינוי הרכוב יעביר מקל או ימשיך בטיפול ויעדכן את המפקד הרפואי בכל טיפול או שינוי במצב הפצוע.

ב. החלטה על סדר העמסה למסוק וחלוקה למסוקים

בהתאם לסדר הגעת הפצועים, דחיפותם וזמינות המסוקים, יקבל המפקד הרפואי יחד עם המפקד האג"מי את ההחלטה על סדר העמסת הפצועים על המסוקים.



באר"ן, **הפצועים הדחופים ביותר יועמסו ראשונים**. במידה ובאירוע מספר מסוקים, לרוב נעדיף להכניס תחילה ינשופים אשר יקחו כל אחד 2 פצועים (הדחופים ביותר), וכאשר יוותרו 6 פצועים ומטה - הם יפוננו ביסעור המאסף.

במצבים חריגים בהם קיימת סכנה ברורה למסוק וההנחיה האג"מית הינה להכניס מסוק אחד בלבד, המשימה תוגדר כמשימת חילוץ ויועמסו מקסימום הפצועים הדחופים על המסוק היחיד שיכנס גם במחיר פגיעה ביכולת הטיפול (בעדיפות יסעור).

ג. סידור הפצועים מחוץ למנחת והכנה לפינוי

במתאר מאוים הכנה נכונה של הפצועים מראש תחסוך זמן קרקע ותפחית את האיום על המסוק.

- **הסרת אמל"ח מהפצוע.**
- **העמסה וקיבוע לאלונקה** – יש "לארוז" את הפצוע היטב כולל קסדה, אטמי אוזניים ומשקפי מגן ככל שניתן, ולאבטח לאלונקה **בדגש על חפיסת שמיכת המילוט** כך שלא תעוף לרוטור המסוק.
- **וידוא קיבוע הגישה למחזור הדם ופרוצדורות** – יש לוודא שכלל הצנרת (גישה למחזור הדם, החייאת נפח או הנשמה) מקובעת היטב על מנת להימנע משליפת הצנרת בזמן העמסה (כלקח מאירועים רבים).
- **הסרת כלל המכשור הרפואי שאינו עולה עם הפצוע למסוק** – כגון מד לחץ דם, מד סטורציה, קין פלואו (המחסנית תישאר עם המטופל ותחובר לקין פלואו אחר על המסוק). לא יתבצע שחלוף של מכשור או חמצן עם הצוות המוסק.
- **קיפול אנטנות קשר של האלונקאים** (מחשש לפגיעה ברוטור).
- **קיפול מוטות טלסקופיים באלונקות** (מקשה על סגירת דלת המסוק ומעכב המראה).
- **הרחקת ציוד שעלול לעוף לרוטור המסוק** – פסולת, שאריות בגדים, חבישות שהוסרו וכו'.
- **הכנת תיעוד רפואי להעברה** – ביצוע העברת מקל מסודרת באמצעות טופס 101 ידני או דיגיטלי.
- **מוכנות לכניסת המסוק** – רגע לפני כניסת המסוק על הצוות להרים את האלונקה לגובה מותננים במוכנות מיידית להתקדם למסוק ולהעמיס את הפצוע לאחר נחיתה. יש לנתק מכשור, אמצעי הנשמה וחמצן, ולעצור (לא לנתק) מתן של מנת דם מלא או פלזמה.



בזמן שנותר עד הגעת המסוק יש להמשיך בטיפול בפצועים. בזמן זה יש לשים דגש על מדידת מדדים חיוניים. אין לעכב כניסת מסוק לצורך טיפול רפואי בקרקע, למעט עצירת דימום פורץ. ניתן לבצע את כלל הטיפולים במסוק תוך כדי פינוי.

7. חבירה בקשר לצוות המוסק

במהלך הפינוי ומוקדם ככל הניתן, על הרמה הממונה להעביר למפקד המנחת ולמפקד הרפואי פרטים אודות המסוקים שהוקצו, בדגש על או"ק וזמן הגעה משוער. עם התקרבות המסוק, המסוק יחבור למפקד המנחת בתג"מ. החבירה למסוק תתבצע לרוב ברשת הקשר של הכוח המסתייע (ברירת המחדל היא תדר מנו"ח). עיקר השיח בשלב זה יהיה סביב תיאום טכני של הנחיתה, וקביעת "אופציה" לנחיתה (ראה הסבר בהמשך). על מפקד המנחת להעביר בשלב זה דיווח תמציתי, אשר יכלול רק את הפרטים הבאים:

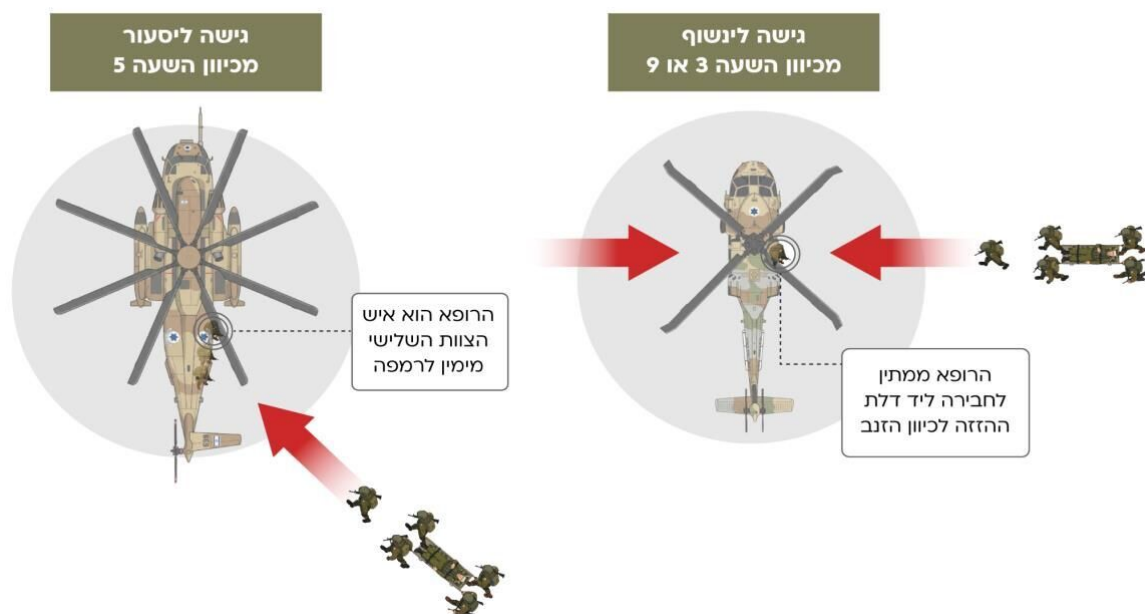
- מספר פצועים שיועמסו על המסוק, כמה בשכיבה וכמה בישיבה.
- פציעות עיקריות (בכותרת).
- תיאום "אופציה" לחבירה למסוק (א', ב' או ג', ראה מטה).
- דיווחים מיוחדים אשר ישפיעו פיזית על החבירה בפתח המסוק, כגון: פצוע מונשם, ביצוע נקודת לחיצה או לחץ ישיר על דימום, דרישה לתספוק דם או חוסר בכ"א בקרקע להעמסת האלונקות למסוק.
- רק לאחר ריכוז הפצועים, החלטה על סדר הפינוי המוסק ומוכנות מלאה של הפצועים והצוות, יתן המפקד בשטח את ההוראה לכניסת המסוק למנחת בתיאום ישיר עם הטייס.
- בשלב זה ישנה חשיבות עליונה לחדל דיבור בקשר למעט המפקד והטייס, כל שיח אחר יתבצע באופן זמני בתדר אחר, למשל בתדר מחו"פ.

8. הגישה למסוק

- קיימות שלוש אפשרויות בחבירה למסוק, והבחירה ביניהן תלויה במתאר המבצעי ובסוג האירוע.
- א. אופציה א': הפצועים מועמסים למסוק ללא פריקה של צוות המסוק לקרקע (ברירת המחדל בלחימה). במנחתים מאויימים (חוצי או סמוכי גב"ל) יש להקפיד שזמן שהות המסוק על הקרקע בחבירה יהיה קצר ככל הניתן (עד 30 שניות). דגשים:
- עם נחיתת המסוק על הפצועים להיות מוכנים כבר על אלונקות המורמות לגובה מותניים, לכל פצוע 4 אלונקאים, והאלונקות באוויר בגובה מותניים.



- **לאחר קבלת סימן מהמכונאי המוטס שניתן להתקרב, הצוות הקרקעי יגיע למסוק בהליכה מהירה (לא בריצה) ויעמיס את הפצועים למסוק, מבלי לעלות עליו.**
 - **על המפקד הרפואי במנחת לרוץ לפני האלונקה ולבצע חבירה תכליתית עם המט"ב במסוק בזמן העמסת הפצועים (למיקום המט"ב במסוק ראה תרשים). החבירה הרפואית תבוצע ע"י מט"ב אחד בלבד, גם באירוע עם מספר פצועים.**
 - **במידה ומתבצע לחץ ישיר על דימום או מתבצעת נקודת לחיצה, על הצוות הקרקעי לדווח על כך מראש בקשר על מנת שבזמן ההעמסה למסוק יהיה מי שיוגדר מראש לבצע לחץ באיזור הדימום. ביצוע נק' לחיצה תוך כדי תנועה של האלונקה למסוק אינו אפקטיבי.**
 - **לאחר העמסת הפצועים יש להתרחק מהמסוק באופן מיידי.**
- במידה ובגזרת הפעולה מתבצע תספוק אלונקות, צר"פ או דם ע"י המסוק (כפי שנקבע בנוה"ק), הנ"ל יזרקו מהמסוק לקרקע. יש לאסוף אותם רק לאחר עזיבת המסוק את המנחת.
- ב. **אופציה ב': צוות המסוק פורק לזמן קצר מהמסוק (ברירת המחדל בשגרה בשטח שאינו מאויים).** בזמן לחימה או בשטח מאויים, הדבר יבוצע רק במידה ויש צורך לסייע לכוח הקרקעי בהעמסת הפצועים בצורה יעילה, תוך שמירה על עיקרון מינימום זמן על הקרקע. בשטח שאינו מאויים או באירוע שגרה, תתבצע חבירה מסודרת בין מטפלים בכירים, בעדיפות בתוך רכב הפינוי כך שיהיה ניתן לבדוד את הצוותים הרפואיים מרעש ורוח המסוק.
- ג. **אופציה ג': הצוות המוסק פורק, המסוק ממריא והצוות נשאר על הקרקע.** המסוק ישוב לקבל את הצוות בהמשך. מתבצע לעיתים נדירות. במתאר מאויים הדבר יתבצע כסיבוב של אופציה ב', באיום מידי על המסוק. במתאר שאינו מאויים, אופציה זו תתבצע לדוגמה, כאשר יש צורך בחילוץ ממושך ועל מנת שרעש המסוק והרוח לא יפריעו לחילוץ.





סיכום

פינוי מוסק הוא אמצעי חשוב בשרשרת הפינוי, התורם לסיכויי ההישרדות של הפצוע, בין היתר בשל מיומנות הצוותים המטפלים והזמן שנחסך עד להגעה לבית חולים. על מנת לבצע את משימת הפינוי המוסק בצורה מיטבית נדרש תיאום הדוק, הכנה של הפצועים, משמעת ותזמון. לצד זאת יש תמיד מקום להפעלת שיקול דעת, בין היתר בעצם החלטה על הפינוי המוסק, תוך שקילת היתרונות והחסרונות שלו.

הכרת הפרוטוקול, תרגול וביצוע תוך שיקול דעת, הם המפתח להצלחת הפינוי ולהצלת חיים.